

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病 Chronic Obstructive Pulmonary Disease ; COPD				
編號	A31000-Q03-W-C06	制定者	N14 李美樺	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.1 版/14 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解慢性阻塞性肺疾病的定義、病理變化、致病機轉、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD，國內簡稱：肺阻塞）是一種暴露於有害顆粒物或氣體造成的氣道或肺泡異常所造成，以持續性呼吸道症狀和慢性氣流受限為特徵。呼氣氣流受阻乃是由小呼吸道疾病（阻塞性細支氣管炎）和肺實質破壞（肺氣腫）所共同導致，同時會破壞肺實質而導致肺泡失去對小呼吸道附著以及肺部喪失回彈力(recoil)，所以削減了呼吸道在呼氣時保持暢通的能力。診斷標準為病人吸入支氣管擴張劑後，若第一秒吐氣量(forced expiratory volume in 1 second, FEV1)/肺活量(forced vital capacity, FVC)比值＜70%，即為慢性阻塞性肺病。

（二）病理變化

主要發生於呼吸道、肺實質以及肺部血管，並可發現特定免疫細胞的出現與增加之慢性發炎病理變化，若反覆發炎反應所造成的傷害與後續修復而導致呼吸道結構改變。

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/15

（三）致病機轉

肺阻塞呼吸道發炎是呼吸道因應菸霧等類慢性刺激物所出現的異常發炎反應；其增強的發炎反應機制不明但可能與基因有關。會助長肺阻塞發生機制有：氧化壓力的產生、肺部蛋白酶調控的失衡、某些特定發炎細胞出現所導致。

（四）症狀

典型症狀為慢性且漸進性的呼吸困難、咳嗽及咳痰。

1. 呼吸困難：是肺阻塞主要症狀，病人常主訴呼吸沉重費力，發作時會感到胸口緊緊、喉嚨癢癢及不能呼吸，似乎無法獲得足夠氧氣的感覺。
2. 咳嗽：慢性咳嗽往往是最早出現的症狀。初期可能只是間歇性咳嗽，慢慢演變成每天咳嗽；部分明顯呼氣氣流受阻的肺阻塞病人甚至沒有咳嗽症狀。
3. 咳痰：肺阻塞病人在咳嗽後常會咳出少量黏痰。連續兩年，每年三個月以上的有痰咳嗽（且無法用其他原因解釋）曾被定義為慢性支氣管炎，但這樣的定義太過籠統，因其無法真正反映肺阻塞的咳痰狀況。有些人習慣將痰吞入而不是咳出，因此真正的痰液產量很難評估。大量咳痰可能是支氣管擴張症的表徵。
4. 哮鳴(wheezing)與胸悶：哮鳴與胸悶屬於非特異性症狀，在不同的日子、甚至同一天內皆可能出現變異。
5. 重度慢性肺阻塞其他特徵：常有疲倦、體重減輕及厭食等症狀。長時間的持續咳嗽令胸腔內壓快速增高易使病人產生咳嗽性昏厥；而劇烈咳嗽也會造成肋骨骨折；若病人有憂鬱和/或焦慮等症狀則應特別注意其臨床病史，因為這些症狀常見於肺阻塞病人，而且可能增加急性惡化風險，並導致健康狀態受損。

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/15

分級	第 1 級	第 2 級	第 3 級	第 4 級
嚴重度	輕度	中度	嚴重	非常嚴重
基本條件	FEV₁/FVC < 70%			
肺功能檢查	FEV ₁ ≥ 80% 預測值	50% ≤ FEV ₁ < 80% 預測值	30% ≤ FEV ₁ < 50% 預測值	FEV ₁ < 30% 或 FEV ₁ < 50% 且伴慢性呼吸衰竭
臨床症狀	可能無症狀，或僅有慢性咳嗽、咳痰。	因活動起來出現呼吸困難，而尋求醫療幫助	反覆惡化，呼吸困難加劇，影響日常生活，可能需要適當治療	呼吸衰竭或右心臟衰竭，有生命危險
備註	此時患者本人可能還沒認識到自己的肺功能是異常的。	此時，由於呼吸困難或疾病的加重，患者常去醫院就診。		

(五) 常見檢查

1. 胸部 X 光。
2. 肺功能檢查。
3. 痰液檢查。
4. 動脈血液氣體分析。
5. 血液檢查。

(六) 常見治療

1. 藥物治療

- (1) 吸入型支氣管擴張劑：分為乙二型交感神經刺激劑(beta2-agonists)與抗膽鹼藥物(anticholinergics)，建議所有的肺阻塞病人急性發作時應給予短效吸入型支氣管擴張劑，作為治療用藥。
- (2) 吸入型類固醇(inhaled corticosteroid, ICS)：是治療肺阻塞的重要藥物之一，但不適用於所有的肺阻塞病人，對於合併氣喘疾病、經常急性發作的肺阻塞病人極為重要。
- (3) 複方吸入型類固醇/支氣管擴張劑：在症狀較嚴重、嚴重肺功能障礙、或急性惡化風險高的病人，建議優先使用固定劑量複方支氣管擴張劑。
- (4) 口服類固醇：對於穩定期肺阻塞病人，若其肺功能欠佳，可以短期使用最低

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/15

劑量的口服類固醇，惟應注意其副作用。

(5)口服茶鹼(theophylline)：穩定期肺阻塞病人，已使用任一種吸入型支氣管擴張劑，若其肺功能仍然不佳，可以使用最低有效劑量的口服茶鹼附加治療來改善其肺功能，惟應注意其副作用。

(6)口服第四型磷酸二酯抑制劑(PDE4 inhibitor)：對於穩定期肺阻塞病人，而且是慢性支氣管炎的臨床表現型者，若其急性惡化頻繁，建議應該使用口服第四型磷酸二酯抑制劑(roflumilast)治療。

(7)連續口服大環內酯類(macrolide)抗生素：對於穩定期肺阻塞病人，已使用 ICS、LABA 和 LAMA(長效型支氣管擴張劑)合併治療後，若仍有一次或以上急性惡化事件，可以使用大環內酯類抗生素(erythromycin 或 azithromycin)附加治療，來減少急性惡化的發生，惟應注意其副作用。

(8)口服化痰藥(mucolytic agents)。

(9)口服乙型交感神經阻斷劑(β -adrenoceptor blocker, β -blocker)：對於穩定期肺阻塞合併冠狀動脈疾病或心衰竭之病人，可以使用心臟選擇性乙型交感神經阻斷劑來改善其預後，惟應注意其肺功能是否下降。

2.非藥物治療

(1) 戒菸所有吸菸的肺阻塞病人，無論其疾病嚴重度為何，強烈建議戒菸。

(2) 疫苗注射：包含肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗注射。所有肺阻塞病人，建議每年接施打流感疫苗以減少肺阻塞的急性發作。

(3) 營養照顧：肺阻塞病人是營養不良的高風險族群，在照護過程應監控其營養狀態並視需要給予適當的營養補充。

(4) 肺部復健：肺部復健可減少呼吸短促之感覺，改善生活品質，減少住院次數及日數，改善肺阻塞急性惡化住院後的康復，亦可加強長效支氣管擴張劑的療效。

(5) 氧氣治療：若患者休息時的動脈氧分壓 55 毫米汞柱以下或血氧飽和度 88% 以下（穩定狀態下測量 2 次並間隔 3 週），無論是否有高碳酸血症，都有長

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/15

時間使用氧氣的需求（一天超過 15 小時），但給氧過多易造成呼吸抑制，使 CO₂ 累積故需特別注意。

(a)nasal cannula：1-2L／min。

(b)venturi mask：依不同 FiO₂(24-28%)設定流量。

(6) 非侵襲性陽壓呼吸器(Non-invasive positive pressure ventilation, NIPPV)：當肺阻塞的病人出現呼吸性酸中毒，或是出現嚴重的呼吸困難，建議使用非侵襲性陽壓呼吸器來治療，可以減少肺阻塞急性發作的住院時間，並可降低因為急性發作導致的插管率與死亡率。

(7) 外科治療：肺氣泡切除術(bullectomy)、肺容積縮減手術(Lung Volume Reduction Surgery, LVRS)、肺臟移植(lung transplantation)、以及支氣管鏡肺容積縮減手術(Bronchoscopic Lung Volume Reduction，BLVR)等。

（七）護理問題

1. 無法有效呼吸／肺擴張不全。
2. 呼吸道清除功能不良／分泌物滯留。
3. 氣體交換困難／換氣與灌流不平衡。
4. 活動耐力不足／氧氣供需不平衡。
5. 焦慮感受／氧氣需求未得到滿足。

（八）護理措施

1. 無法有效呼吸／肺擴張不全
 - (1) 評估呼吸狀況，記錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和分泌物的特性。
 - (2) 監測脈搏血氧定量法和動脈血液氣體分析值。
 - (3) 依醫囑送檢體做培養、細胞學和敏感試驗。
 - (4) 協助病人採高坐臥姿，至少每 2 小時翻身一次以移動分泌物。
 - (5) 教導病人深呼吸後有效咳嗽。
 - (6) 必要時抽吸呼吸道，抽吸時間以 10 秒為限。
 - (7) 抽吸前後先給予氧氣或鼓勵深呼吸。

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/15

- (8) 依醫囑執行胸部物理治療，例如叩擊、姿位引流。
- (9) 提供病人足夠氧合狀態，鼓勵經口攝取液體或依醫囑維持靜脈輸液。
- (10) 依醫囑給予濕潤的氧氣，尤其當病人身上有人工氣管時。
- (11) 依醫囑給予藥物，例如支氣管擴張劑、類固醇、祛痰劑和抗生素。
- (12) 記錄護理措施的效果。

2. 呼吸道清除功能不良／分泌物滯留

- (1) 評估和記錄病人呼吸狀況，包括完整的健康史。
- (2) 評估和記錄病人呼吸型態，包括速率、節律、肺部擴張、呼吸音、是否使用呼吸輔助肌、噤嘴呼吸、動脈血液氣體分析值和皮膚顏色。
- (3) 教導和協助最有效呼吸姿勢，例如：噤嘴呼吸時採三點姿勢。
- (4) 指導並示範如何深呼吸和咳嗽，並 2-4 小時做一次。
- (5) 維持足夠營養攝取量以供呼吸肌和呼吸所需的熱量。
- (6) 教導病人避免呼吸道刺激物和呼吸道感染。
- (7) 依醫囑給予藥物和評估效果，例如：支氣管擴張劑、抗發炎藥物等。
- (8) 評估動脈血液氣體分析值、肺功能和病人一般臨床狀況改善情形。
- (9) 病人呼吸急促時，鼓勵家屬陪伴、給予精神上的支持。
- (10) 依醫囑給予氧氣治療，並評估治療效果。

3. 氣體交換困難／換氣與灌流不平衡

- (1) 監測組織缺氧的徵象包括心智狀況改變、心跳過速、易怒和異常呼吸音，並報告醫師。
- (2) 必要時監測動脈血液氣體分析值、心電圖和血氧監測。
- (3) 鼓勵咳嗽和深呼吸以維持呼吸道。
- (4) 協助保持呼吸道通暢的方法，例如：咳嗽和深呼吸、胸部物理治療、抽吸、蒸氣吸入法等。
- (5) 置病人於換氣和灌流能達最佳狀態的姿勢，例如：半坐臥、坐臥。
- (6) 依醫囑給予藥物，包括支氣管擴張劑、祛痰劑、抗生素等。

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/15

(7) 依醫囑給予氧氣治療，並評估治療效果。

4. 活動耐力不足／氧氣供需不平衡

- (1) 活動前後測量生命徵象並比較，必要時監測心電圖變化。
- (2) 和病人討論調整活動的必要性，以減少心臟工作負荷的要求，並發展個別化及漸進式的活動。
- (3) 協助病人日常生活活動，評估活動無耐力的程度和提供休息時間以保留體力。
- (4) 依醫囑服用藥物可促進活動的耐力。
- (5) 依醫囑給予氧氣使用並建議病人採半坐姿或坐姿。
- (6) 向病人或家屬說明活動耐受力之影響因子。
- (7) 教導學習或練習鬆弛技巧以避免促使減少活動無耐力的情形。
- (8) 教導當病人有疼痛或疲累情形產生時，應終止或減少活動。
- (9) 教導病人或家屬省力的方法，避免等長運動、槓桿原理。
- (10) 教導病人監測自己對活動的生理反應，有助於評估日常生活的活動度。

5. 焦慮感受／氧氣需求未得到滿足

- (1) 評估病人焦慮程度及主要原因。
- (2) 利用行為或認知策略，教導病人規律的呼吸、放鬆的技巧及冥想來減輕恐懼。
- (3) 安排病人喜歡的環境，分散注意力，減輕恐懼，例如：聽音樂、聊天。
- (4) 經常探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。
- (5) 請家屬陪伴並給予心理支持。
- (6) 恐懼感持續無法改善，必要時依醫囑給予鎮靜藥物治療。
- (7) 引導病人參與予自我照護。

(九) 衛教指導

1. 促進呼吸道通暢

除了使用一些醫藥處方、氧氣來輔助控制慢性阻塞性肺部疾病，亦可使用不同

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/15

的呼吸方式緩解不適，例如：噤嘴呼吸法、橫膈膜呼吸法，此種呼吸法可提供更多的氧氣進入肺中，防止呼吸急促的情形。

(1) 噤嘴呼吸法

噤嘴式呼吸係以半開嘴唇之方式延長主動呼氣時間，如此可避免呼吸道塌陷，有助降低呼吸速率、呼吸困難、提升潮氣容積等。當運動量較大時，所需氧氣增加，此方法可以吐出更多肺裡的空氣，即可吸入更多的氧氣，當執行上下樓梯、舉重物等會造成呼吸急促的動作時，便可運用此呼吸方式來預防肺泡塌陷。

- A. 先鬆弛頸部、肩膀肌肉，由鼻子吸氣，持續約數二下的時間。
- B. 將嘴唇噤起似吹哨子，由口吐氣約持續相當數四下或更長的時間。
- C. 注意事項：吐氣時間一定需比吸氣時間長，保持吐氣時間至少是吸氣時間的兩倍。當行某些行為時，例如：提舉重物、彎腰、伸手拿東西千萬別閉氣。

(2) 橫膈式呼吸

橫膈式呼吸是著重在利用橫膈膜的上下運動來代替輔助肌肉，以達最大吸氣量，可防止呼吸急促現象。

- A. 首先採舒適姿勢（坐著、躺著），膝蓋彎曲、放鬆頸部及肩膀。
- B. 一手置於胸部，另一手置於腹部，慢慢由鼻吸氣數二下，同時會感到腹部的手有上提的感覺。
- C. 慢慢呼氣，數四下，縮緊腹部。
- D. 注意事項：吸氣時，放鬆下腹部肌肉讓橫膈膜往下移動，如此才可有足夠氧氣進入肺中，所以呼氣時請縮小腹。

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	9/15

2. 運動療法

運動為肺部復健之主要元素，雖然無法直接改善患者肺部功能，但可增加患者肌肉中有氧酵素濃度、增進肌肉強度、運動耐受力，並降低因肌肉耐力不佳而加劇之呼吸困難。

(1) 選擇運動項目

剛開始運動會有呼吸不順之情形，先慢慢增加耐力，運動項目包含：跑步機、走路、游泳、騎腳踏車及輕量舉重開始訓練。務必遵照醫生指示，在運動前使用短效支氣管擴張劑或供給氧氣。

(2) 如何開始運動增加耐力

把運動當成生活中不可或缺的一部份，慢慢的開始進行，以增加活動耐力，目標為一星期運動 3-5 次，每次持續 20 分鐘至半小時以上。

- A. 運動前先做暖身運動，例如：拉筋、彎腰。結束後做一些溫和的拉筋動作，可防止肌肉酸痛、抽筋。
- B. 一種運動一次只要做 2-3 分鐘即可，一天中再重複 4-5 次。運動時呼吸急促的情形可使用噍嘴呼吸法來控制。
- C. 慢慢增加運動量，記下每天的活動量，每週或每天運動時都比之前多運動一分鐘即可幫助增強耐力。
- D. 若已經可以舒服持續運動 20-30 分鐘，則可增加運動次數或加快速度。
- E. 當感到身體不適，可將運動時間分段進行，若感到頭暈、胸悶、心悸、嚴重呼吸急促時，一定要立刻停止運動。

3. 如何正確飲食

健康均衡飲食可提供足夠的熱量保持理想體重，均衡的飲食包含：肉類、乳製品（全脂）、水果、蔬菜。

(1) 保持理想體重

體重太輕，比較沒體力且易受感染。體重過重易出現呼吸急促的現象。每星期定期檢查體重兩次，若有以下兩種情形發生，立刻回診：

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	10/15

A. 體重每星期或每月持續下降，表示可能熱量攝取不足。

B. 在二到四天內體重就增加 1.5 公斤，可能是水分滯留有水腫情形發生。

(2) 採流質飲食

流質食物可幫助稀釋肺內部分黏液使之較易排出。例如：礦泉水、果汁。

而含有咖啡因的茶、咖啡、可樂加糖飲料及酒類則應避免。

(3) 在進食間或飯後有呼吸急促的現象，而影響進食，可參考以下方法：

A. 避免產氣和太多碳水化合物食物並少量多餐，使橫膈膜不受限，而肺部比較有膨脹空間。

B. 細嚼慢嚥，嘴巴盡量不要張開，以免胃部吸入空氣。

C. 吃飯前後避免運動。

4. 戒菸

香菸是慢性支氣管炎和肺氣腫的首要原因，會使氣管收縮、分泌多餘的黏液，而香菸的毒氣會影響血液的攜氧量至全身，讓病情更加惡化，唯有停止抽菸才是控制肺部疾病最有效之方法。

5. 減少肺部感染的機會

(1) 常洗手，因為病菌的傳染大多由手傳口來做為媒介。

(2) 每年接種疫苗。

(3) 不要經常出入公共場所、人多的地方，尤其是冬天。出入公共場所記得戴口罩。

(4) 養成持續運動的習慣，維持正常健康的飲食和充足的睡眠。

6. 控制壓力並嘗試放鬆自己

(1) 當感到壓力時，呼吸會開始急促，頸部、肩膀、胸肌均會緊繃，此時呼吸肌肉疲乏，空氣堆積在肺中無法進出，而變的更加甚至喘不過氣來。此時可運用之前介紹的噉嘴式呼吸法、橫膈式呼吸法使呼吸回復平順。

(2) 如何放鬆自己

盡可能避免會驚慌失措的情形，假如出現呼吸急促情形，找個安靜地方讓

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	11/15

自己鬆弛，閉眼休息，用橫膈呼吸法數分鐘，亦可嘗試以下方式：

A. 想像療法：想像自己正在做喜歡的事、或自己正身處在清靜環境中。

B. 練習放鬆：將身體每一部份（從腳指到頭皮），在吸氣時慢慢的拉緊肌肉，持續繃緊約數秒，在呼氣時放鬆。

(3) 其他：瑜珈、冥想、練太極、聽音樂等。

7. 其他注意事項：

早期發現早期治療，如有下列徵兆時，請趕快回診：

- (1) 發燒、發冷。
- (2) 胸口緊縮感，吃平時服用的藥物無效時。
- (3) 呼吸急促現象越來越嚴重、哮鳴或咳嗽不停。
- (4) 痰量增多，痰中帶血絲，有異味，顏色呈現黃色或綠色。
- (5) 不規則的心跳。
- (6) 足踝水腫。

(十) 實施及修訂

本辦法經委員會護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 王桂芸、李惠玲(2020)．呼吸系統疾病之護理．於劉雪娥總校閱．台北：華杏，1144-1155。

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	12/15

- (二) 劉人華、周佳佩、潘柏霖 (2024) · 慢性阻塞性肺病2023臨床新指引 · 家庭醫學與基層醫療, 39 (11) , 332-340。
- (三) 吳尚軒、黃繩龍、黃煒霖 (2021) · 慢性阻塞性肺病的診斷與治療 · 家庭醫學與基層醫療, 36(3), 72-79。
- (四) 台灣胸腔暨重症加護醫學會 (2023) · 台灣肺阻塞臨床照護指引 ·
<https://www.tspccm.org.tw/media/7073>
- (五) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. (2023). Global strategy for the prevention, diagnosis and management of COPD: 2023 report. GOLD.
<https://goldcopd.org/2023-gold-report-2/>

七、附件

(略)

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	13/15

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定。	97 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	(1)修改說明內容錯字與修辭。 (2)病患改病人。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	醫護部修改成護理部。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭。	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	說明內容修辭潤飾及修正標點符號。	103 年 08 月 31 日通過護理部照護標準委員會。
104.08.31	3.3	1. 第三項說明內容部份刪修。 2. 第六項參考資料文獻部份內容更新。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.4	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 更新第三項第(一)、(二)、(三)、(六)目之內容。 3. 更新第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.5	1. 第三項第(一)、(二)、(四)、(六)目之內容部份增刪。 2. 更新第六項參考文獻資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.6	1. 第一項新增病理變化、致病機轉。 2. 第二項新增（含中興分院）。 3. 第六項第七目參考資料刪除。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	14/15

修正日期	版本	修正說明	備註
108.09.23	3.7	1. 第三項第一、四目新增說明內容。 2. 第三項第九目之 1(1)、2、5(1) 新增說明內容。 3. 第三項第十日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 4. 第六項新增參考資料。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.07	3.8	1. 第三項第一、二、三、四目之內容部份增刪。 2. 更新第六項參考文獻資料。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過； 110 年 08 月 11 日護理長會議通過;110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	3.9	1. 第三項第四目之 1.及第三項第八目之 1.(7)、第三項第九目之 3.(2)內容部份增刪。 2. 更新第三項第七、八目護理問題。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過;111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	4.0	更新第六項參考文獻資料。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	4.1	1.第三項第四目說明內容疾病分期部份增刪。 2.第六項參考資料文獻部份內容更新。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。

主題名稱	慢性阻塞性肺疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	15/15

修正日期	版本	修正說明	備註